

Fecha Última Actualización: 30-08-2022 11:15:14

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Ricardo Alfonso Arcos Silva
Edad : 35a 8m 1d
Dirección : Psj Haiti 3262 V Sotero Del Rio

Rut : 16.539.473-9
Fecha Nacto: 29/12/1986
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2200176
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8739 5904

N° Epicrisis
311079

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 04/06/2022 01:13

Días Estadía: 87

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 30/08/2022 11:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR y UCI: 04/06/22
FI UTIM: 13/06/22
FI Sala: 15/06/22
FI UTIM (2°): 18/06/22
FI Sala (2°): 19/07/22
FI UTIM (3°): 26/08/22

Antecedentes:

- Mórbitos: Sd. nefrótico maligno, biopsia informa GSFS con daño podocitario difuso, en el estudio, Anti PLA2R (-), gen podocitario (-) para variantes patogénicas. En HD para manejo de volumen por tunelizado instalado el 03/05.
- Quirúrgicos: Hernioplastia inguinal.
- Fármacos: Enalapril 5 mg cada 12 h, Carvedilol 3.125 mg cada 12 h, Espironolactona 125 mg/día, Prednisona 20 mg/día, Bicarbonato de sodio 1 g cada 8 h, Atorvastatina 40 mg, Elcal D 1 comprimido, Cotrimoxazol forte 1 comprimido trisemanal, ácido fólico 5 mg/día, EPO 4000 U trisemanal, omeprazol 20 mg/día.
- Alergias: Ninguna.
- Hábitos: TBQ (+) ocasional, OH (+) ocasional, Drogas (-)
- Hospitalizaciones: Múltiples por sd. nefrótico desde 2021 en HPH y HSR, manejado con pulsos de corticoides, ciclofosfamida y tacrolimus, última 21/04 al 05/05/22 por CVC disfuncional e ITU por KPN BLEE, se administró Rituximab en dicha oportunidad presentando RAM grave.

Historia de ingreso:

Datos rescatados de ficha y por familiares. Paciente con antecedentes descritos, última HD efectiva el 03/06, ingresa por cuadro de 24 horas de evolución de desorientación, agitación, agresividad y CEG, evolucionando con pérdida de control de esfínteres, mirada perdida y sin conectar con el medio. Al ingreso a UEA se describe vigil, agresivo, sin respuesta a órdenes, taquicárdico, febril, con edema generalizado, sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. Al laboratorio inicial destaca hipocalcemia leve, hipokalemia, alcalosis respiratoria y elevación de parámetros inflamatorios, con orina inflamatoria y HC (+) CGP a las 6 horas. TAC de cerebro sin lesiones agudas, TAC TAP con derrame pleural bilateral leve. Se intentó PL en 3 ocasiones, frustra, y se inició manejo empírico con Ceftriaxona, Vancomicina, Ampicilina y Aciclovir, además se instaló nuevo CHD transitorio en plan de descartar tunelizado como foco. Evolucionó con shock séptico profundo, por lo que se conectó a VMI e ingresó a UCI, destacando anemia hasta 4.2 y trombocitopenia en 26.000 dentro del laboratorio de control.

Fecha Epicrisis : 30/08/2022 11:15

Página 1 de 3

Evolución

1. Hemodinamia: Al ingreso cursa con shock séptico profundo, en retrospectiva, deterioro inicial se atribuyó a shock hemorrágico por hematoma en sitio de inserción de CHD FD. Durante hospitalización con múltiples episodios de caída de Hemoglobina, AngioTAC 26/06 con hematoma pancreático, además presenta múltiples episodios de hematemesis tras autoinducción de vómitos, EDA 26/07 informa esofagitis erosiva distal grado C. Se mantuvo con IBP.

2. Ventilatorio: VMI por shock séptico, evoluciona favorablemente, extubado el 09/06.

Evoluciona con deterioro respiratorio el 27/08, requirió CNAF con parámetros elevados. Se define por equipo tratante, nefrología y CCPP no oncológicos que no se beneficia de intubación.

Se inicia manejo de confort con BIC de Fentanilo.

Evoluciona con insuficiencia respiratoria catastrófica.

3. Infeccioso:

a. Al ingreso cursa shock séptico asociado a compromiso cualitativo de conciencia, manejado como meningitis tras intentos frustrados de PL, con ceftriaxona, ampicilina, aciclovir y, además Vancomicina por HC (+) CGP. Al rescatar HC (+) S. agalactiae MS, se ajustó tratamiento a Ampicilina + Gentamicina, además se realizó PL en UCI, anodina y con estudio (-); tras 9 días se cambió a ampicilina sulbactam.

b. Infección por COVID 16/06, se mantuvo sin requerimientos de O2. 22/06 sospecha de sobreinfección, recibió Tazonam empírico. Además, el 25/06 se agrega diarrea, manejada con Vancomicina por 10 días.

c. 25/06 se realiza RM cerebro que muestra Pioventriculitis, ajustando esquema a Meropenem + Vancomicina. PL del 29/06 con 8 células, cultivo y film array (-). Evaluado por infectología impresiona infección de SNC por S. agalactiae pesquisado al ingreso. Se controló RM 14/07, sin cambios, se decala tto a amoxicilina clavulánico, con plan de completar 14 días.

2. Medio interno: ERC en HD para manejo de volúmenes, se descartó foco en tunelizado. En cuanto a nefrótico y GSFS, se mantiene con corticoides de uso crónico, se controló proteinuria de 24 h (20 g) y se ajustó manejo farmacológico sin respuesta, por lo que el 11/07 se emboliza arteria renal derecha y el 11/08 izquierda, con mala respuesta y persistencia de proteinuria masiva hasta 30g que no responde a medidas habituales.. No se logró nefrectomía quirúrgica por performance status y gran desnutrición.

3. Neurológico: Al ingreso se sospechó meningitis, siendo descartada por infectología. TAC de cerebro sin lesiones agudas, sin embargo, evolucionó con compromiso cualitativo de conciencia persistente, aparentes crisis de ausencia y rigidez. EEG del 11/06 informa actividad epileptiforme interictal central bilateral, por lo que se inició manejo con ácido valproico, con buena respuesta. Al seguimiento por neurología se ajustó a AV, fenitoína y diazepam, en plan de decaje de fenitoína mientras mantenga niveles de AV en rango, último EEG 06/07 normal. Evoluciona con sospecha de pioventriculitis por imagen cerebral.

4. Hematológico y tromboembólico: Al ingreso evoluciona con anemia y trombocitopenia, se atribuyó a hematoma por inserción de CHD transitorio, AngioTAC mostró escaso sangrado retroperitoneal. Además, con hallazgo de TVP femoral derecha al ingreso, y de TEP en AngioTAC del 26/06, anticoagulación suspendida por hematoma pancreático y otros sangrados. El 11/07 se instaló filtro VCI.

5. Digestivo: Por dolor abdominal y anemización, se realizó AngioTAC 26/06 encontrando hematoma pancreático. ColangioRM del 30/06 muestra hemorragia pancreática con extensa colección hacia retroperitoneo, rx. intervencional desestimó punción. Al seguimiento imagenológico, sin sangrado activo.

6. Nutricional y Metabólico: Evoluciona con desnutrición CP severa, en relación a interurrencias infecciosas y proteinuria masiva, manejado con nutrición parenteral de forma transitoria, actualmente aportes por SNG. Destaca tendencia a la hipoglicemia, con cortisol AM normal.

7. Psiquiátrico: En seguimiento por equipo de psicología y medicina integrativa, rechaza sesiones, impresiona trastorno adaptativo y desmoralizante. Se ha mantenido en manejo con lorazepam, haloperidol y quetiapina, en plan de controlar neuroimagen.

8. Cuidados paliativos: Evaluado por equipo (Dra Olivares): Se define como Sd Nefrótico como enfermedad terminal que determina su pronóstico ominoso en conjunto con Nefrología. Sugieren suspensión de medidas e inicio de opiáceos.

9. Social: Padre Fernando enterado de la situación actual. Se dejó como tutor para cualquier información o eventualidad: 982376596

Evoluciona con insuficiencia respiratoria catastrófica.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

·Insuficiencia Respiratoria Aguda Catastrófica

·Pioventriculitis por S. agalactiae MS

·Epilepsia

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 30-08-2022 11:15:14

Página 3 de 3

- Hematoma pancreático
- TEP y TVP femoral derecha -> Filtro VCI
- Proteinuria masiva -> Embolización bilateral de arterias renales
- Esofagitis erosiva grado C
- Hipoglicemias
- Desnutrición CP severa
- Trastorno desmoralizante / adaptativo
- Previos: Infección por COVID, Sd. diarreico agudo, shock hemorrágico y séptico, bacteremia por S. agalactiae MS.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece el 30/08/22 a las 09:30 am.

Plan Post Alta

Se de aviso a familiares.
Se realiza certificado de defunción.

Indicaciones

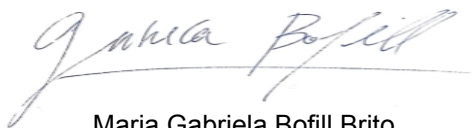
Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

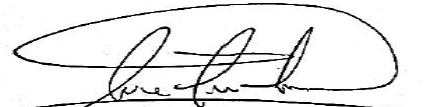
Controles

INTERNO



Maria Gabriela Bofill Brito

Becado/Residente



Mario Alex Contreras Torrez

Médico Tratante (Staff)